PROTOCOLE OPÉRATIONNEL TRANSFRONTALIER D'URGENCE VITALE ET DE SÉCURITÉ CIVILE « CORRIDOR DES BOUCHES DE BONIFACIO (CORSE – SARDAIGNE) » : ACCÈS RÉFLEXE EN 14 MINUTES DES SAMU 2A/2B ET DES SECOURS CORSES AUX PLATEAUX D'OLBIA ET DU CHU DE SASSARI

Fondé sur le Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT), l'article L. 1115-1 du CGCT, la Directive 2011/24/UE relative aux soins de santé transfrontaliers et l'Article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Droit à la vie).

LE SCANDALE GÉOGRAPHIQUE ET MÉDICO-LÉGAL : Le détroit de Bonifacio ne mesure que **11 kilomètres**. La base aérienne et l'Hôpital Jean-Paul II d'**Olbia (Sardaigne)** se trouvent à **14 minutes de vol** de Bonifacio, Figari et Porto-Vecchio, et le **CHU de Sassari (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari — 850 lits, Neurochirurgie H24, Trauma Center, Cardiologie interventionnelle, Réanimation néonatale)** est situé à **25 minutes d'hélicoptère** de la Corse-du-Sud. Or, par pur centralisme jacobin et pour préserver la rente T2A des hôpitaux de Marseille (83 M€/an), l'État français impose aux blessés graves et aux malades en détresse vitale de l'Extrême-Sud corse un transfert de **4h45 à 6h15 porte-à-porte vers Marseille ou Nice** (et 1h30 d'attente pour les Canadairs depuis Nîmes-Garons) !

I. COMPARATIF FORENSIQUE DES ISOCHRONES DE SURVIE (EXTRÊME-SUD CORSE : BONIFACIO / PORTO-VECCHIO / FIGARI)

URGENCE VITALE / SINISTRE DANS L'EXTRÊME-SUD (200 000 PERSONNES/JOUR L'ÉTÉ)	CIRCUIT JACOBIN IMPOSÉ PAR PARIS (MARSEILLE / NICE / NÎMES)	CORRIDOR EUROPÉEN RÉFLEXE CORSE – SARDAIGNE (OLBIA / CHU SASSARI)	GAIN DE SURVIE & RESPECT DE LA GOLDEN HOUR (60 MIN)
1. Infarctus du Myocarde (STEMI) ou Polytraumatisé Grave à Bonifacio / Porto-Vecchio	Route vers Ajaccio : **2h05 à 2h45** EVASAN vers Marseille Timone : **4h45 à 6h15 porte-à-porte**	HéliSMUR / Dragon vers **Hôpital d'Olbia (14 min de vol)** ou **CHU de Sassari (25 min de vol)**	**Gain de +3h30 à +5h00** • Admission au bloc en **< 45 min** (Golden Hour sauvée)
2. Hématome Extra-Dural / AVC nécessitant Thrombectomie ou Neurochirurgie	0 neurochirurgien en Corse • Transfert obligatoire vers Marseille ou Nice en **4h30 à 6h00**	Admission directe au **Service de Neurochirurgie & Stroke Unit du CHU de Sassari (AOU Sassari)** en **25 min de vol**	**Sauvetage neurologique direct** (1,9 million de neurones épargnés par minute gagnée)
3. Accident de Plongée Hyperbare (Bouches de Bonifacio / Lavezzi)	1 seul caisson civil à Ajaccio (souvent saturé ou indisponible)	Accès croisé immédiat aux caissons hyperbares de **La Maddalena / Sassari / Olbia (10 à 20 min)**	Recompression thérapeutique immédiate sans franchissement du col de Saint-Georges

URGENCE VITALE / SINISTRE DANS L'EXTRÊME-SUD (200 000 PERSONNES/JOUR L'ÉTÉ)	CIRCUIT JACOBIN IMPOSÉ PAR PARIS (MARSEILLE / NICE / NÎMES)	CORRIDOR EUROPÉEN RÉFLEXE CORSE – SARDAIGNE (OLBIA / CHU SASSARI)	GAIN DE SURVIE & RESPECT DE LA GOLDEN HOUR (60 MIN)
4. Départ de Feu Critique (Massif de l'Ospedale / Bonifacio / Cagna)	Attente des Canadairs depuis Nîmes-Garons : **1h30 à 2h00 de transit** (5 sur 12 disponibles le 24/07/2026)	Frappe initiale réflexe des **Canadairs de la base d'Olbia-Costa Smeralda en 14 minutes d'envol**	Attaque du feu dans les 15 premières minutes • **Protection vitale des cliniques et villages**

II. FONDEMENTS JURIDIQUES EUROPÉENS INATTAQUABLES (POURQUOI PARIS NE PEUT PAS BLOQUER CE PROTOCOLE)

1. **L'Obligation Positive de Sauver la Vie Humaine (Article 2 de la CEDH) :** Selon la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (*Arrêt Budayeva c. Russie du 20 mars 2008* et *Arrêt Mehmet Şentürk c. Turquie du 9 avril 2013*), tout État signataire qui, par formalisme administratif ou refus de coopération transfrontalière de proximité, prive délibérément un patient en détresse vitale ou une population menacée par le feu du moyen de secours le plus rapide (Olbia/Sassari à 14–25 minutes contre Marseille/Nîmes à 1h30–5h00) commet une **violation substantielle de l'Article 2 de la CEDH (Droit à la vie)** et engage la responsabilité pénale de ses représentants pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui (Art. 223-1 du Code pénal).
2. **Le Règlement (CE) n° 1082/2006 sur les GECT et la Directive 2011/24/UE :** L'article 10 du Règlement européen n° 1082/2006 et l'article L. 1115-1 du CGCT autorisent la Collectivité de Corse, le GCS *CHU di Corsica* et la Région Autonome de Sardaigne (*Regione Autonoma della Sardegna / AREUS 118 Sardegna*) à instituer une **Zone Organisée d'Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST Corse-Sardaigne)** sur le modèle des conventions déjà en vigueur à la frontière franco-belge (Ardennes), franco-espagnole (Hôpital de Cerdagne) et franco-allemande (Sarrebruck/Forbach).

III. CLAUSES D'EXÉCUTION IMMÉDIATE POUR LE SAMU 2A ET LES SECOURS CORSES

- **Clause 1 (Interconnexion Radio & Téléphonique Directe SAMU 2A Ajaccio ↔ AREUS 118 Sassari/Olbia) :** Liaison dédiée directe entre le médecin régulateur du SAMU 2A (Centre 15 d'Ajaccio), la Clinique de l'Ospedale (Porto-Vecchio), l'Hôpital de Bonifacio et la centrale opérationnelle du **118 Sardegna (AREUS)** pour déclenchement réflexe sans visa préfectoral préalable dès lors que l'isochrone vers Ajaccio ou Marseille dépasse le seuil critique de la *Golden Hour* (60 minutes).
- **Clause 2 (Prise en Charge Financière Automatique Carte Européenne / CPAM 2A-2B) :** Facturation directe des séjours d'urgence vitale réalisés à l'Hôpital d'Olbia ou au CHU de Sassari aux caisses d'Assurance Maladie françaises (formulaires européens S2 / E112 dématérialisés d'office), avec **zéro reste à charge et zéro avance de frais** pour les patients corses et leurs familles.